

Splénomégalie

Physiopathologie, Diagnostic

Pr Ag Imen Frikha

27 Août 2025

Objectifs

1. Etablir le diagnostic positif d'une splénomégalie à partir des données cliniques et radiologiques.
2. Expliquer les mécanismes physiopathologiques à l'origine d'une splénomégalie.
3. Décrire les circonstances de découverte d'une splénomégalie.
4. Différencier par l'examen clinique et l'imagerie médicale une splénomégalie d'une autre masse de l'hypochondre gauche.
5. Réunir les arguments anamnestiques et cliniques permettant l'orientation du diagnostic étiologique en fonction de l'âge.
6. Planifier les examens complémentaires à réaliser chez un patient présentant une splénomégalie, en fonction de l'orientation étiologique.

A retenir

- Diagnostic d'une SMG est **clinique** et repose sur la **palpation**.

- Patient en **décubitus dorsal**, à plat, genoux fléchis.
- Examineur placé du **côté droit** du patient, et palper l'abdomen avec la **main droite** bien à **plat** en remontant de la fosse iliaque jusque sous l'HCG.
- Masse de l'HCG, **superficielle**, **mobile** avec la respiration, à **bord antérieur crénelé** et **ne donnant pas le contact lombaire**

- Le débord splénique est mesuré en **Cm**, à partir du **rebord costal** sur la **ligne mamelonnaire** jusqu'au point le plus extrême de la rate.

- Patient en **décubitus latéral droit**, cuisse gauche fléchie à 45°. Doigts de l'examineur étant placés **en crochet** sous le rebord costal.

- Imagerie: **non indispensable**
- Utilité: en cas de **doute** ou dans les **cas difficiles** (ascite, obésité, paroi abdominale tonique).

- **Echographie** abdominale: confirme la nature splénique de la masse palpée (taille, homogénéité et autres Aliés (ADP, HMG, HTP).

A retenir

Mécanismes physiopathologiques

- Une hyperplasie splénique
- Une augmentation de la pression dans le système porte ou la veine splénique
- Une métaplasie myéloïde de la rate
- Une prolifération cellulaire maligne (lymphoïde+++)
- Une surcharge lors de certaines maladies métaboliques.

Conséquences de la splénomégalie

- Hypersplénisme avec cytopénies modérées par séquestration splénique.
- Hémodilution : par augmentation du volume plasmatique.
- Hypertension portale
- Diminution des taux de facteur V et de cholestérol

A retenir

Circonstances de découverte

- La splénomégalie est le plus souvent **indolore**.
- Examen clinique : « **fortuite** » tableau clinique évocateur conduisant à la recherche d'une grosse rate (**fièvre, HMG, ADPs périphériques, HTP, ictère cutanéomuqueux**)
- Troubles fonctionnels : **pesanteur** ou **douleur de l'HCG**, **signes digestifs** (sensation de **plénitude gastrique**, **troubles dyspeptiques**, **douleurs abdominales**)
- Anomalies de l'hémogramme : **thrombopénie, leucopénie, leuco neutropénie, anémie**, voire une pancytopénie, présence de cellules anormales dans le sang;
- Plus rarement, par complications : **infarctus splénique** (des douleurs du flanc et/ou bas thoraciques gauches : fièvre souvent présente ; l'échographie ou le scanner confirme le diagnostic). La **rupture de la rate** (tableau de choc hémorragique, souvent précédé par des douleurs qui doivent faire rechercher un hématome sous-scapulaire splénique par l'échographie ou le scanner).

A retenir

Diagnostic différentiel

- **Un Gros rein gauche** : mais la masse est plus postérieure, avec contact lombaire, immobile a l'inspiration profonde ;
 - **Une tumeur de l'angle colique gauche**: parfois antérieure mais immobile, avec un pole inférieur mal limite et un bord antérieur non crénelé
 - **Un kyste ou une tumeur de la queue du pancréas**
 - **Une hypertrophie du lobe gauche hépatique**
- ☐ En cas de doute diagnostique clinique, l'imagerie (scanner abdomino-pelvien) permet d'authentifier le diagnostic.

A retenir

Etiologies selon l'âge

	Enfant	Adulte
Étiologies des SMG	Les infections virales	Les syndromes lympho-prolifératifs
	Les anémies hémolytiques constitutionnelles	Les syndromes myélo-prolifératifs
	Les maladies de surcharge	Les anémies hémolytiques acquises
	Les leucémies aiguës	Les maladies inflammatoires
		Hypertension portale

QCM

Une splénomégalie est recherchée à l'examen clinique chez un patient en:

- A. Décubitus ventral
- B. Position assise
- C. Décubitus latéral gauche
- D. Décubitus dorsal
- E. Décubitus latéral droit

QCM

Une splénomégalie est recherchée à l'examen clinique chez un patient en:

- A. Décubitus ventral
- B. Position assise
- C. Décubitus latéral gauche
- D. Décubitus dorsal**
- E. Décubitus latéral droit**

QCM

Une splénomégalie est recherchée à l'examen clinique au niveau :

- A. Du flanc gauche
- B. Du flanc droit
- C. De l'hypochondre droit
- D. De l'hypochondre gauche
- E. De l'ombilic

QCM

Une splénomégalie est recherchée à l'examen clinique au niveau :

- A. Du flanc gauche
- B. Du flanc droit
- C. De l'hypochondre droit
- D. De l'hypochondre gauche**
- E. De l'ombilic

QCM

Une splénomégalie est une masse :

- A. Localisée au niveau de l'hypochondre gauche
- B. De siège postérieur
- C. Mobile à l'inspiration profonde
- D. A bord antérieur non crénelé
- E. Donnant le contact lombaire

QCM

Une splénomégalie est une masse :

- A. Localisée au niveau de l'hypochondre gauche
- B. De siège postérieur
- C. Mobile à l'inspiration profonde
- D. A bord antérieur non crénelé
- E. Donnant le contact lombaire

QCM

La mensuration d'une splénomégalie est appréciée:

- A. En centimètre du rebord costal
- B. En travée de doigts du rebord costal
- C. En centimètre de l'ombilic
- D. A partir de la dernière côte non flottante et sur la ligne médio-claviculaire
- E. En combinant une percussion thoracique à une palpation abdominale

QCM

La mensuration d'une splénomégalie est appréciée:

- A. En centimètre du rebord costal
- B. En travée de doigts du rebord costal
- C. En centimètre de l'ombilic
- D. A partir de la dernière côte non flottante et sur la ligne médio-claviculaire
- E. En combinant une percussion thoracique à une palpation abdominale

Le débord splénique doit être mesuré, à partir du rebord costal sur la ligne mamelonnaire jusqu'au point le plus extrême de la rate, à l'aide d'un mètre ruban.

QCM

Une splénomégalie est vérifiée radiologiquement par:

- A. Une Radiographie thoracique
- B. Une Echographie abdominale
- C. Un Abdomen sans préparation (ASP)
- D. Un arbre urinaire sans préparation (AUSP)
- E. Une bili-IRM

QCM

Une splénomégalie est vérifiée radiologiquement par:

- A. Une Radiographie thoracique
- B. Une Echographie abdominale**
- C. Un Abdomen sans préparation (ASP)
- D. Un arbre urinaire sans préparation (AUSP)
- E. Une bili-IRM

QCM

Le diagnostic d'une splénomégalie repose sur :

- A. Anamnèse
- B. Examen physique
- C. Échographie abdominale
- D. Biopsie splénique
- E. Arguments biologiques

QCM

Le diagnostic d'une splénomégalie repose sur :

- A. Anamnèse
- B. Examen physique
- C. Échographie abdominale
- D. Biopsie splénique
- E. Arguments biologiques

QCM

A propos de la splénomégalie :

- A. L'examen radiologique est indispensable pour le diagnostic de SMG
- B. L'échographie abdominale permet de confirmer le diagnostic de SMG
- C. L'échographie abdominale permet de renseigner sur l'aspect de la SMG
- D. L'échographie abdominale permet parfois d'orienter le diagnostic étiologique
- E. Une SMG est retenue par une flèche splénique supérieure à 13 cm à l'échographie

QCM

A propos de la splénomégalie :

- A. L'examen radiologique est indispensable pour le diagnostic de SMG
- B. L'échographie abdominale permet de confirmer le diagnostic de SMG
- C. L'échographie abdominale permet de renseigner sur l'aspect de la SMG
- D. L'échographie abdominale permet parfois d'orienter le diagnostic étiologique
- E. Une SMG est retenue par une flèche splénique supérieure à 13 cm à l'échographie

L'échographie abdominale confirme la nature splénique de la masse palpée, visualise la taille de la rate et renseigne sur l'homogénéité (kyste, hématome), et visualisera d'éventuelles anomalies associées (hépatomégalie, adénopathies profondes, signes d'hypertension portale).

Elle permet de retenir la splénomégalie quand la flèche échographique est ≥ 13 cm.

QCM

L'imagerie au cours d'une splénomégalie est indiquée si :

- A. Abscès splénique
- B. Candidose splénique
- C. Maladie de Gaucher
- D. Signes d'hypertension portale
- E. Lupus érythémateux systémique

QCM

L'imagerie au cours d'une splénomégalie est indiquée si :

- A. Abcès splénique
- B. Candidose splénique
- C. Maladie de Gaucher
- D. Signes d'hypertension portale
- E. Lupus érythémateux systémique

QCM

Le mécanisme physiopathologique d'une splénomégalie pourrait être :

- A. Une hyperplasie splénique
- B. Une congestion par hypertension portale
- C. Une augmentation de la séquestration des globules rouges
- D. Une infiltration tumorale
- E. Une surcharge en fer

QCM

Le mécanisme physiopathologique d'une splénomégalie pourrait être :

- A. Une hyperplasie splénique
- B. Une congestion par hypertension portale
- C. Une augmentation de la séquestration des globules rouges
- D. Une infiltration tumorale
- E. Une surcharge en fer

QCM

Le mécanisme physiopathologique d'une splénomégalie pourrait être :

- A. Une hyperplasie splénique
- B. Une congestion par hypertension artérielle
- C. Une augmentation de la séquestration des globules rouges
- D. Une infiltration tumorale
- E. Un dépôt de substances amyloïdes

QCM

Le mécanisme physiopathologique d'une splénomégalie pourrait être :

- A. Une hyperplasie splénique
- B. Une congestion par hypertension artérielle
- C. Une augmentation de la séquestration des globules rouges
- D. Une infiltration tumorale
- E. Un dépôt de substances amyloïdes

QCM

Une splénomégalie peut être découverte par :

- A. Des douleurs de l'hypocondre gauche
- B. Une pesanteur de l'hypocondre gauche
- C. Des épigastralgies
- D. Une sensation de plénitude gastrique
- E. Peut être asymptomatique

QCM

Une splénomégalie peut être découverte par :

- A. Des douleurs de l'hypocondre gauche
- B. Une pesanteur de l'hypocondre gauche
- C. Des épigastralgies
- D. Une sensation de plénitude gastrique
- E. Peut être asymptomatique

QCM

La circonstance de découverte d'une splénomégalie pourrait être :

- A. Une douleur de l'hypochondre droit irradiant en bretelle à l'épaule droit
- B. Une anémie isolée
- C. Une pancytopenie souvent modérée
- D. Fortuite par l'examen physique
- E. Une pesanteur de l'hypochondre gauche

QCM

La circonstance de découverte d'une splénomégalie pourrait être :

- A. Une douleur de l'hypochondre droit irradiant en bretelle à l'épaule droit
- B. Une anémie isolée
- C. Une pancytopenie souvent modérée
- D. Fortuite par l'examen physique
- E. Une pesanteur de l'hypochondre gauche

QCM

Une splénomégalie pourrait être confondue à l'examen clinique à:

- A. Une tumeur gastrique
- B. Une hypertrophie du foie droit
- C. Une tumeur de la queue du pancréas
- D. Une tumeur du pôle supérieur du rein droit
- E. Une tumeur de l'angle colique droit

QCM

Une splénomégalie pourrait être confondue à l'examen clinique à:

- A. Une tumeur gastrique
- B. Une hypertrophie du foie droit
- C. Une tumeur de la queue du pancréas**
- D. Une tumeur du pôle supérieur du rein droit
- E. Une tumeur de l'angle colique droit

QCM

Une splénomégalie pourrait être confondue à l'examen clinique à:

- A. Une tumeur gastrique
- B. Une hypertrophie du foie gauche
- C. Une tumeur de la queue du pancréas
- D. Une tumeur du pôle supérieur du rein droit
- E. Une tumeur de l'angle colique droit

QCM

Une splénomégalie pourrait être confondue à l'examen clinique à:

- A. Une tumeur gastrique
- B. Une hypertrophie du foie gauche
- C. Une tumeur de la queue du pancréas
- D. Une tumeur du pôle supérieur du rein droit
- E. Une tumeur de l'angle colique droit

QCM

Les conséquences de la SMG pourraient être :

- A. Des cytopénies sévères
- B. Des cytopénies prédominantes sur les plaquettes
- C. Des cytopénies avec moelle pauvre
- D. Hypertension portale d'apport
- E. Hémodilution

QCM

Les conséquences de la SMG pourraient être :

- A. Des cytopénies sévères
- B. Des cytopénies prédominantes sur les plaquettes
- C. Des cytopénies avec moelle pauvre
- D. Hypertension portale d'apport
- E. Hémodilution

QCM

L'association d'une SMG et circulation veineuse collatérale fait évoquer :

- A. Une hépatite aigue
- B. Une leucémie aigue
- C. Une cirrhose
- D. Un lymphome
- E. Un syndrome de Budd Chiari

QCM

L'association d'une SMG et circulation veineuse collatérale fait évoquer :

- A. Une hépatite aigue
- B. Une leucémie aigue
- C. Une cirrhose**
- D. Un lymphome
- E. Un syndrome de Budd Chiari**

QCM

Une splénomégalie peut se voir dans la (les) infections bactérienne(s) suivante (s):

- A. Le Paludisme
- B. La fièvre Typhoïde
- C. La Brucellose
- D. La Tuberculose
- E. La Mononucléose

QCM

Une splénomégalie peut se voir dans la (les) infections bactérienne(s) suivante (s):

- A. Le Paludisme
- B. La fièvre Typhoïde
- C. La Brucellose
- D. La Tuberculose
- E. La Mononucléose

QCM

Une splénomégalie peut se voir dans la (les) infections virale(s) suivante (s):

- A. Le Kala-azar
- B. La Rickettsiose
- C. La toxoplasmose
- D. La Rubéole
- E. La Mononucléose

QCM

Une splénomégalie peut se voir dans la (les) infections virale(s) suivante (s):

- A. Le Kala-azar
- B. La Rickettsiose
- C. La toxoplasmose
- D. La Rubéole**
- E. La Mononucléose**

QCM

Une splénomégalie peut se voir dans la (les) infections parasitaire(s) suivante (s):

- A. La Leishmaniose viscérale
- B. Le Paludisme
- C. La toxoplasmose
- D. La septicémie à Pyogène
- E. La primo-infection par le VIH

QCM

Une splénomégalie peut se voir dans la (les) infections parasitaire(s) suivante (s):

- A. La Leishmaniose viscérale
- B. Le Paludisme
- C. La toxoplasmose
- D. La septicémie à Pyogène
- E. La primo-infection par le VIH

QCM

Une splénomégalie peut se voir dans la (les) infections parasitaire(s) suivante (s):

- A. La Leishmaniose cutanée
- B. Le Paludisme
- C. La toxoplasmose
- D. La septicémie à Pyogène
- E. La primo-infection par le VIH

QCM

Une splénomégalie peut se voir dans la (les) infections parasitaire(s) suivante (s):

- A. La Leishmaniose cutanée
- B. Le Paludisme**
- C. La toxoplasmose**
- D. La septicémie à Pyogène
- E. La primo-infection par le VIH

QCM

La fièvre Typhoïde associe:

- A. Une splénomégalie
- B. Une leucopénie
- C. Une diarrhée glairo-sanglante
- D. Une sérologie de Wright positive
- E. Une fièvre en plateau

QCM

La fièvre Typhoïde associe:

- A. Une splénomégalie
- B. Une leucopénie
- C. Une diarrhée glairo-sanglante
- D. Une sérologie de Wright positive
- E. Une fièvre en plateau

QCM

La Brucellose associe:

- A. Une splénomégalie
- B. Une leucopénie
- C. Une diarrhée glairo-sanglante
- D. Une sérologie de Widal positive
- E. Une fièvre suduro-algique

QCM

La Brucellose associe:

- A. Une splénomégalie
- B. Une leucopénie
- C. Une diarrhée glairo-sanglante
- D. Une sérologie de Widal positive
- E. Une fièvre suduro-algique

QCM

Une splénomégalie fait partie du tableau clinique de :

- A. L'anémie par carence en fer
- B. L'anémie par carence en vitamine B12
- C. L'aplasie médullaire
- D. L'anémie par hyperhémolyse
- E. L'anémie par saignement

QCM

Une splénomégalie fait partie du tableau clinique de :

- A. L'anémie par carence en fer
- B. L'anémie par carence en vitamine B12
- C. L'aplasie médullaire
- D. L'anémie par hyperhémolyse**
- E. L'anémie par saignement

QCM

Une splénomégalie fait partie du tableau clinique de :

- A. L'anémie ferriprive
- B. L'anémie de Biermer
- C. L'aplasie médullaire
- D. La microsphérocytose de Minkowski Schauffard
- E. L'anémie par rupture de varice œsophagien

QCM

Une splénomégalie fait partie du tableau clinique de :

- A. L'anémie ferriprive
- B. L'anémie de Biermer (fausse)
- C. L'aplasie médullaire
- D. La microsphérocytose de Minkowski Schauffard**
- E. L'anémie par rupture de varice œsophagien

QCM

Une splénomégalie fait partie du tableau clinique de :

- A. Les syndromes drépanocytaires majeurs de l'adulte
- B. La drépanocytose double hétérozygote S/C
- C. L'anémie ferriprive
- D. La Microsphérocytose de Minkowski Schauffard
- E. Déficit en glucose 6 phosphate déshydrogénase

QCM

Une splénomégalie fait partie du tableau clinique de :

- A. Les syndromes drépanocytaires majeurs de l'adulte
- B. La drépanocytose double hétérozygote S/C
- C. L'anémie ferriprive
- D. La Microsphérocytose de Minkowski Schauffard
- E. Déficit en glucose 6 phosphate déshydrogénase

QCM

Une anémie hémolytique associe :

- A. Une pâleur
- B. Un ictère
- C. Une splénomégalie
- D. Des urines foncées
- E. Un syndrome neuro-anémique

QCM

Une anémie hémolytique associe :

- A. Une pâleur
- B. Un ictère
- C. Une splénomégalie
- D. Des urines foncées
- E. Un syndrome neuro-anémique

QCM

Une anémie hémolytique associe :

- A. Une anémie normocytaire régénérative
- B. Une anémie macrocytaire régénérative
- C. Une augmentation des bilirubines conjuguées
- D. Une baisse de l'haptoglobine
- E. Une augmentation des LDH

QCM

Une anémie hémolytique associe :

- A. Une anémie normocytaire régénérative
- B. Une anémie macrocytaire régénérative
- C. Une augmentation des bilirubines conjuguées
- D. Une baisse de l'haptoglobine
- E. Une augmentation des LDH

QCM

Le diagnostic de la Sphérocytose héréditaire se fait par :

- A. La recherche de Sphérocytes au frottis sanguin
- B. L'étude de l'électrophorèse de l'Hémoglobine
- C. L'étude de l'électrophorèse des protéines sériques
- D. L'étude de la résistance globulaire
- E. Le dosage enzymatique de la G6PD

QCM

Le diagnostic de la Sphérocytose héréditaire se fait par :

- A. La recherche de Sphérocytes au frottis sanguin**
- B. L'étude de l'électrophorèse de l'Hémoglobine
- C. L'étude de l'électrophorèse des protéines sériques
- D. L'étude de la résistance globulaire**
- E. Le dosage enzymatique de la G6PD

QCM

Le diagnostic de l'anémie hémolytique auto-immune se fait par :

- A. L'étude du test de Coombs directe
- B. L'étude des anticorps anti-nucléaires
- C. L'étude du Facteur Rhumatoïde
- D. L'étude de myélogramme
- E. L'étude de l'immunofixation des protéines sériques

QCM

Le diagnostic de l'anémie hémolytique auto-immune se fait par :

- A. L'étude du test de Coombs directe**
- B. L'étude des anticorps anti-nucléaires
- C. L'étude du Facteur Rhumatoïde
- D. L'étude de myélogramme
- E. L'étude de l'immunofixation des protéines sériques

QCM

Une splénomégalie fait partie du tableau clinique de :

- A. La maladie de Hodgkin
- B. La leucémie lymphoïde chronique
- C. L'aplasie médullaire
- D. La maladie de Waldenstrom
- E. Déficit en G6PD

QCM

Une splénomégalie fait partie du tableau clinique de :

- A. La maladie de Hodgkin
- B. La leucémie lymphoïde chronique
- C. L'aplasie médullaire
- D. La maladie de Waldenstrom
- E. Déficit en G6PD

QCM

Une splénomégalie fait partie du tableau clinique de :

- A. La leucémie aigue lymphoblastique
- B. La leucémie lymphoïde chronique
- C. La leucémie à Tricholeucocytes
- D. Le myélome multiple
- E. Le lymphome splénique

QCM

Une splénomégalie fait partie du tableau clinique de :

- A. La leucémie aigue lymphoblastique
- B. La leucémie lymphoïde chronique
- C. La leucémie à Tricholeucocytes
- D. Le myélome multiple
- E. Le lymphome splénique

QCM

Une splénomégalie fait partie du tableau clinique de :

- A. La leucémie myéloïde chronique
- B. La myélofibrose primitive
- C. Le myélome multiple
- D. La polyglobulie primitive
- E. La Leucémie myélomonocytaire chronique

QCM

Une splénomégalie fait partie du tableau clinique de :

- A. La leucémie myéloïde chronique
- B. La myélofibrose primitive
- C. Le myélome multiple
- D. La polyglobulie primitive
- E. La Leucémie myélomonocytaire chronique

QCM

Une splénomégalie fébrile avec leuconéutropénie fait évoquer :

- A. Une brucellose
- B. Une fièvre typhoïde
- C. une candidose viscérale
- D. Une mononucléose
- E. Une rickettsiose

QCM

Une splénomégalie fébrile avec leuconeutropénie fait évoquer :

- A. Une brucellose
- B. Une fièvre typhoïde
- C. une candidose viscérale
- D. Une mononucléose
- E. Une rickettsiose

QCM

L'association d'une pancytopénie et d'une splénomégalie peut évoquer :

- A. Une aplasie médullaire
- B. Une anémie réfractaire
- C. Une leucémie aigue
- D. Une leucémie lymphoïde chronique stade A
- E. Un myélome multiple

QCM

L'association d'une pancytopenie et d'une splénomégalie peut évoquer :

- A. Une aplasie médullaire
- B. Une anémie réfractaire
- C. Une leucémie aigue**
- D. Une leucémie lymphoïde chronique stade A
- E. Un myélome multiple

QCM

Le tableau clinique d'une LMC en phase chronique associe:

- A. Une hyperleucocytose avec myélémie
- B. Une splénomégalie
- C. Une translocation t(9,22)
- D. Un réarrangement moléculaire bcr-abl
- E. Un taux de blaste > 20% au myélogramme

QCM

Le tableau clinique d'une LMC en phase chronique associe:

- A. Une hyperleucocytose avec myélémie
- B. Une splénomégalie
- C. Une translocation t(9,22)
- D. Un réarrangement moléculaire bcr-abl
- E. Un taux de blaste > 20% au myélogramme

QCM

Une splénomégalie fait partie du tableau clinique de :

- A. La maladie de Still
- B. La maladie périodique
- C. Lupus systémique
- D. La sarcoïdose
- E. Syndrome de Felty

QCM

Une splénomégalie fait partie du tableau clinique de :

- A. La maladie de Still
- B. La maladie périodique
- C. Lupus systémique
- D. La sarcoïdose
- E. Syndrome de Felty

QCM

Le syndrome de Felty associe:

- A. Une splénomégalie
- B. Une polyarthrite Rhumatoïde
- C. Une neutropénie profonde
- D. Des adénopathies médiastinales
- E. Un érythème du visage

QCM

Le syndrome de Felty associe:

- A. Une splénomégalie
- B. Une polyarthrite Rhumatoïde
- C. Une neutropénie profonde
- D. Des adénopathies médiastinales
- E. Un érythème du visage

QCM

Une splénomégalie fait partie du tableau clinique de :

- A. La maladie de Gaucher
- B. La maladie de Niemann Pick
- C. L'amylose
- D. L'hémochromatose
- E. Toutes les réponses sont fausses

QCM

Une splénomégalie fait partie du tableau clinique de :

- A. La maladie de Gaucher
- B. La maladie de Niemann Pick
- C. L'amylose
- D. L'hémochromatose
- E. Toutes les réponses sont fausses

QCM

Parmi les diagnostics suivants lequel ou lesquels s'accompagne(nt) d'une splénomégalie fébrile :

- A. Septicémie à pyogènes
- B. Syndrome myéloprolifératif chronique
- C. Maladie de gaucher
- D. Maladie de still
- E. Mononucléose infectieuse

QCM

Parmi les diagnostics suivants lequel ou lesquels s'accompagne(nt) d'une splénomégalie fébrile :

- A. Septicémie à pyogènes**
- B. Syndrome myéloprolifératif chronique
- C. Maladie de gaucher
- D. Maladie de still**
- E. Mononucléose infectieuse**

QCM

Quel est l'anomalie de l'hémogramme évoquant une splénomégalie par hypertension portale

- A. La présence de lymphocytes activés
- B. Une anémie microcytaire avec thrombopénie
- C. Une thrombocytose
- D. Une hyperleucocytose avec myélémie
- E. Une lymphocytose chronique

QCM

Quel est l'anomalie de l'hémogramme évoquant une splénomégalie par hypertension portale

- A. La présence de lymphocytes activés
- B. Une anémie microcytaire avec thrombopénie**
- C. Une thrombocytose
- D. Une hyperleucocytose avec myélémie
- E. Une lymphocytose chronique

QCM

La découverte d'une splénomégalie impose en première intention :

- A. Une biopsie ostéo-médullaire
- B. Un bilan hépatique
- C. Un scanner abdominal
- D. Un bilan d'hémolyse
- E. Un hémogramme avec numération de réticulocytes et frottis sanguin

QCM

La découverte d'une splénomégalie impose en première intention :

- A. Une biopsie ostéo-médullaire
- B. Un bilan hépatique**
- C. Un scanner abdominal
- D. Un bilan d'hémolyse**
- E. Un hémogramme avec numération de réticulocytes et frottis sanguin**

Cas clinique 1

Enfant âgé de 5 ans admis pour fièvre évoluant depuis deux mois avec asthénie.

A l'examen on note:

- Pâleur cutanéomuqueuse
- Une fièvre à 38,5°
- Une SMG volumineuse

Hémogramme: GB= 4,5 G/L, Hb=4,8 g/dl, plaquettes= 72 G/L

VS accélérée à 80 mm H1

EPP: protidémie = 85 g/l, une hypoalbuminémie et une hypergammaglobulinémie polyclonale

La recherche d'anticorps anti-leishmania est positive

Le myélogramme montre de nombreux amastigotes de leishmanies

Cas clinique 1

QCM1- les données cliniques faisant évoquer la leishmaniose viscérale sont :

- A. L'âge inférieur à 5 ans
- B. Les diarrhées
- C. La triade: fièvre, pâleur, SMG
- D. Le caractère douloureux de la SMG
- E. Le caractère irrégulier de la fièvre

Cas clinique 1

QCM1- les données cliniques faisant évoquer la leishmaniose viscérale sont :

- A. L'âge inférieur à 5 ans
- B. Les diarrhées
- C. La triade: fièvre, pâleur, SMG
- D. Le caractère douloureux de la SMG
- E. Le caractère irrégulier de la fièvre

Cas clinique 1

QCM2- les données biologiques faisant évoquer la leishmaniose chez cet enfant sont :

- A. Le syndrome inflammatoire biologique
- B. Le taux de leucocytes
- C. Le caractère polyclonal de l'hypergammaglobulinémie
- D. La pancytopénie
- E. L'hypoalbuminémie

Cas clinique 1

QCM2- les données biologiques faisant évoquer la leishmaniose chez cet enfant sont :

- A. Le syndrome inflammatoire biologique
- B. Le taux de leucocytes
- C. Le caractère polyclonal de l'hypergammaglobulinémie
- D. La pancytopénie
- E. L'hypoalbuminémie

Cas clinique 1

QCM3- les arguments confirmant le diagnostic parasitaire de leishmaniose sont :

- A. La mise en évidence de corps de leishmanies sur myélogramme
- B. La PCR positive sur sang
- C. La présence d'anticorps sériques anti-leishmania
- D. L'hémoculture
- E. La culture positive du prélèvement médullaire sur milieu spécifique

Cas clinique

QCM3- les arguments confirmant le diagnostic parasitaire de leishmaniose sont :

- A. La mise en évidence de corps de leishmanies sur myélogramme
- B. La PCR positive sur sang
- C. La présence d'anticorps sériques anti-leishmania
- D. L'hémoculture
- E. La culture positive du prélèvement médullaire sur milieu spécifique

Cas clinique 2

Un garçon de 12 ans, issu d'un mariage consanguin, est adressé pour pâleur, ictère intermittent et pesanteur de l'hypochondre gauche.

ATCD: père splénectomisé

À l'examen : splénomégalie à 5 cm du rebord costal gauche, subictère conjonctival, absence d'adénopathies.

Biologie :

Hémogramme : Hb = 8,5 g/dl, VGM = 95 fl, réticulocytes = 200 000/mm³,

Le frottis sanguin montre des sphérocytes+++.

Bilan d'hémolyse: Bilirubine libre augmentée, LDH élevées, haptoglobine effondrée.

Cas clinique 2

QCM1- Devant ce tableau clinique et biologique, le diagnostic le plus probable ?

- A. Anémie hémolytique auto-immune chaude
- B. Sphérocytose héréditaire (maladie de Minkowski-Chauffard)
- C. Déficit en pyruvate kinase
- D. Drépanocytose homozygote
- E. Bêta-thalassémie majeure

Cas clinique 2

QCM1- Devant ce tableau clinique et biologique, le diagnostic le plus probable ?

- A. Anémie hémolytique auto-immune chaude
- B. Sphérocytose héréditaire (maladie de Minkowski-Chauffard)**
- C. Déficit en pyruvate kinase
- D. Drépanocytose homozygote
- E. Bêta-thalassémie majeure

Cas clinique 2

QCM2- Les examens complémentaires qui confirment l'hémolyse intra-tissulaire sont :

- A. Haptoglobine sérique effondrée
- B. LDH augmentées
- C. Hyperbilirubinémie libre prédominante
- D. Électrophorèse de l'hémoglobine avec HbF élevée
- E. Numération des réticulocytes augmentée

Cas clinique 2

QCM2- Les examens complémentaires qui confirment l'hémolyse intra-tissulaire sont :

- A. Haptoglobine sérique effondrée
- B. LDH augmentées
- C. Hyperbilirubinémie libre prédominante
- D. Électrophorèse de l'hémoglobine avec HbF élevée
- E. Numération des réticulocytes augmentée

Cas clinique 2

QCM3- Les examens complémentaires qui permettent d'orienter vers l'étiologie sont :

- A. Myélogramme
- B. Test de résistance osmotique globulaire
- C. Test d'autohémolyse corrigée par le glucose
- D. Électrophorèse de l'hémoglobine
- E. Dosage enzymatique de la pyruvate kinase

Cas clinique 2

QCM3- Les examens complémentaires qui permettent d'orienter vers l'étiologie sont :

- A. Myélogramme
- B. Test de résistance osmotique globulaire
- C. Test d'autohémolyse corrigée par le glucose
- D. Électrophorèse de l'hémoglobine
- E. Dosage enzymatique de la pyruvate kinase